



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ايمان عبدالمحسن عبده احمد

العنوان : 0

الحى / المدينة : الشراييه

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 27-09-2026

رقم البطاقة : 26302200103224 رقم التليفون : 01124633700

العمر (تاريخ الميلاد) : 20-02-1963 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: إيمان عبدالمحسن عبده احمد National ID: 26302200103224	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

بمطابقة تحقيق الشخصية

عبد المحسن عبد الله احمد
ابن
الشرابية - القاهرة
م. ش. قاسم السعدني

[illegible]

W4397736



٢٠٣٣/٠٣ ٢١٣٠٢٠٠١٠٣٢٢٢
رَبِّهِ هَمَزَل

أرملة

مسلمة

انثى

البطاقة مصرية حتى ٢٠٣٠/٠٣/٠٢





MDT FORM 20 / 8 / 2025 G

Name	اسماء محمد عبد الله	MRN	
Age	61 yrs	ID	٤١٧٥١٤
Menopausal status	Postmenopausal	Phone	١١٩٦٧٢٦٩٥٥
NRS SCORE		Marital status	متزوج
BMI		Family history	
CO morbidity	Stroke 2014	REASON OF MDT	

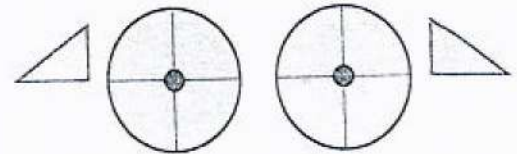
Clinical Data

BX: Pleomorphic lobular carcinoma

R

L

ER: 8/8 PR: 4/8 HER 2: +3 Ki67:



Sonomammography:

Mets Workup:

Free

TNM

Reccom: MACT ACX4 → 12X 7days + Anti Her2neu

Recommendations: Pt is on Adjuvant Hormonal TH, to continue as is for 7 yrs.

MDT OUTCOME & PLAN

To Continue on - Femara
- Celebrex
- VitD

- Zolmet every 6 weeks.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric



Ministry of Health
Central Health Laboratory
Pathology Department

Immunohistochemistry report

Report Number: m5059

Female

الجنس

المرضى

23/09/2020 08:48

29/09/2020 09:56

تاريخ استلام العينة
تاريخ التقرير

العمر
57 Y

معدة مامبر
معدة مامبر

اسم المريض
المسكن
تاريخ اخذ العينة
ملاحظات التحليل
خاتمة

رقم
نوع العينة
حالة

Primary Sample:

Paraffin Block

Test:

ER & PR & HER2 neu (ER&PR: Histo staining system - Her2neu: DAB staining system)

Comment:

Technique:

Sample received was treated by: CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (1E2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample received was treated by: VENTANA anti-HER2/neu (1B6) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection Kit on Ventana Benchmark GX.

Result:

ER: strong nuclear staining of 80 % of tumour cells
PR: moderate nuclear staining of 5 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression: strong continuous membrane staining of > 10 % of tumour cells.

Referral Lab:

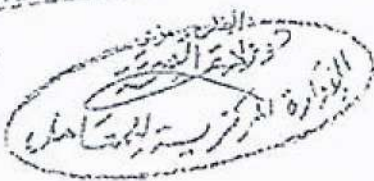
Comment:

Conclusion:

ER: POSITIVE (SCORE 3/8)
PR: POSITIVE (SCORE 4/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION: POSITIVE (SCORE 3+) (CORE BIOPSY)

Lab Director: د/ فريز مامبر

Pathologist:



13 El-Shorh Rehan Street, Azekka, Cairo
Tel: (755) 7943544 - 7950096 Fax: (202) 7945544
Mobile: 01144297292
Email: pathology@technoscan.com
www.technoscan.com

* This Test is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By ICA

يتم الاعتماد بأصل النتيجة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها



Patient Name: Eman Abd Al Mohsen Abdou Ahmed	Date : 20/03/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 4175/2020	Pat. ID: 10880

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM in

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

20/03/2025 2:04 PM



Patient Name: Eman Abd Al Mohsen Abdou Ahmed	Date : 04/12/2024
Exam : C.T CHEST	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 4175/2020	Pat. ID: 10880

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST:

As compared to the last available study dated 20/04/2024, the current study shows:

- Left mastectomy with clear operative bed.
- **Rather stationary course** regarding the previously seen:
 - Relatively reduced volume of left lung.
 - Partial collapse and cystic bronchiectatic changes of the lingula.
 - Left basal calcified pleural plaque.
 - Few prominent mediastinal (retrocaval and aorto-pulmonary) lymph nodes.
- Enlarged cardiac size; for echocardiography correlation.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- No pericardial effusion detected.
- Multiple aortic calcified atheromatous plaques.
- **Still noted** enlarged heterogeneous thyroid lobes with right sided calcific focus for ultrasound correlation.
- Dorsal spondylosis.
- Upper abdominal cuts show GB stones and para-aortic tiny lymph nodes.

OPINION:

- **Status follow up showing stationary course since last dated study.**

Dr. Yasser Rashad, MSc

Signature Prof. Ibrahim Elsedawy
29/01/2025 7:23 PM

Patient Name: Eman Abd Al Mohsen Abdou Ahmed	Date : 20/04/2024
Exam : MRI BRAIN	Age : 61 Year(s)
Medical ID: 4175/2020	

MRI STUDY OF THE BRAIN

Technique of Examination:

- Axial T1, T2 & FLAIR WIs
- Sagittal T2WIs

MR Findings:

- Bilateral deep white matter periventricular sheets and subcortical of areas of abnormal bright T2 and FLAIR signal are seen with multiple bilateral periventricular and subcortical white matter small lacunar infarcts.
- No definite intra cranial masses on non-contrast base.
- No signs of intra cranial bleeding.
- Mild bilateral symmetrical dilatation of the ventricular system.
- Prominent cortical sulci, sylvian fissures and basal cisterns.
- No mid line shift.
- Relative decrease in size of the brain stem and cerebellum with small pontine bright T2 foci.
- Intact cervicomedullary junction.

Opinion:

- Brain involutinal changes.
- Subcortical arteriosclerotic leukoencephalopathy with multiple bilateral cerebral lacunar infarcts, Fazekas-II.
- No definite worrisome intra-cranial masses on non-contrast base, for further evaluation by contrast enhanced study if clinically indicated

Much Obliged,
Dr. Sherif Sameh, M.D.



Patient Name: Eman Abd Al Mohsen Abdou Ahmed	Date : 08/01/2024
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 61 Year(s)
Medical ID: 4175/2020	Pat. ID: 10880

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- average in size (about 15 cm at the right MCL), bright coarse echopattern. No focal lesion could be seen.
No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent .

Gall Bladder: -

- contracted upon multiple stones in side , CBD is not dilated.

Spleen: -

- average size, displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

- Are of normal size , site , with no gross stones or backpressure changes ,
Mild increase in echogenicity
simple right renal upper zone cortical cyst = 15 mm in diameter.

Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion. -

No ascites .

URINARY BLADDER: Normal filling. Normal wall thickness, no stones or diverticulae or solid lesion detected.

Uterus : unremarkable
adenxal mass or cyst.

Opinion:

Parenchymal liver disease.
Bilateral renal mild increase in echogenicity more at the right side (grade I nephropathy) for laboratory correlation
Chronic calcular cholecystitis.
Right renal cyst.
Colonic gaseous distention.

Signature Dr . Nermien Ramadan

08/01/2024 4:45 PM

Patient Name: Eman Abdel-Mohsen

Date: 26/12/2021

^{99m}Tc - ^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information: skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- Unfortunately, the previous bone scan film is not available for comparison, however, in comparison to previous report the current scan revealed:
- No newly developed since last study.
- No appreciable change could be detected since last study
- Still noted;
- Degenerative changes are noticed over dorso-lumbar vertebrae.
- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected alloyer the surveyed skeleton.
- Both kidneys are seen.